UE D1.1 · SEMESTRE 1 · 26 OCTOBRE 2026

RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ ET ÉCOUTE ACTIVE

Fiche de révision écrite

Domaine D1 — Savoir-être, communication professionnelle et leadership

Support de séance et notes de cours

FIL CONDUCTEUR

Partir des mots et des signes observés chez la personne, identifier un besoin relationnel, proposer une présence adaptée et ne pas imposer sa propre interprétation.

Priorités explicitement annoncées par l'enseignante

- Identifier un besoin relationnel dans une situation de soin.
- Définir le soin relationnel.
- Identifier les six attitudes de Porter.
- Analyser sa propre manière de répondre à une personne en situation de vulnérabilité.
- Mobiliser l'écoute active pour prendre soin.

Repères de révision déduits du support

Distinguer la compréhension de l'interprétation ; reconnaître une vraie question ouverte ; différencier les quatre types de reformulation ; respecter les silences ; réguler ses émotions de professionnel.

POINT SUR LES ÉVALUATIONS

L'enseignante indique que ces notions sont importantes et que des questions de communication pourraient être posées aux évaluations. Elle précise toutefois que les sujets n'étaient pas encore construits : les QCM d'entraînement ne sont pas des annales confirmées.

Références pédagogiques : support de séance du 26 octobre 2026 (60 diapositives) et explications de l'enseignante. Les exemples de Mme Paulette et les objectifs proviennent de ces sources.

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Communication et besoin relationnel	p. 2–5	Attitudes de Porter	p. 6–8
Rogers et entretien	p. 9–12	Émotions et accompagnement	p. 13–16
Confusions et synthèse	p. 17–18	Lexique final	p. 19–21

01 Communication adaptée et congruence

Communiquer de manière adaptée ne signifie pas seulement « donner les bonnes informations ». La séance rappelle la cohérence entre les **paroles et le non-verbal**, l'écoute des besoins et des demandes, ainsi que l'adaptation au niveau de compréhension et à la disponibilité psychique du patient.

Repère	Concrètement
Congruence	Alignement entre ce que le soignant pense, dit et fait.
Compréhension	S'assurer que l'autre peut recevoir et comprendre l'information.
Disponibilité	Adapter sa posture, sa place, son regard et son rythme.
Prise en compte du vécu	Ne pas substituer le discours du professionnel à ce que la personne exprime.

À RETENIR

Dire « je vous écoute » ne suffit pas si l'attitude corporelle manifeste l'inverse. La congruence est une cohérence observable.

02 Communication : les deux QCM du support officiel

Quiz 1 — communication adaptée

Sur la diapositive 3, deux énoncés sont retenus par l'enseignante : l'adéquation entre verbal et non-verbal (congruence) et l'adaptation aux aptitudes psychologiques de la personne.

Proposition du cours	Pourquoi la retenir / l'écarter
Accord entre le verbal et le non-verbal	Oui : cohérence entre paroles et attitudes ; notion de congruence.
Besoins sans prendre en compte les demandes	Non : les demandes du patient doivent également être entendues.
Adaptation aux aptitudes psychologiques	Oui : état émotionnel, niveau de compréhension et réceptivité.
Soignant debout devant un patient allongé	Non comme position systématiquement adaptée : ajuster les positions et la symétrie.
Verbal toujours supérieur au non-verbal	Non : impossible de hiérarchiser systématiquement les canaux de cette manière.

Quiz 2 — distinguer les canaux de communication

Les diapositives 5 et 6 interrogent les composantes de la parole. L'enseignante explique notamment que la gestuelle relève du non-verbal : elle ne peut pas être rangée en bloc dans les composantes verbales.

Canal	Repères évoqués pendant la séance
Verbal	Mots, formulation, contenu du message.
Paraverbal	Intonation, musicalité, débit, timbre, intensité et silences.
Non verbal	Gestes, posture, regard, mimiques, distance entre les personnes.

DISTINCTION À MAÎTRISER

Ne pas assimiler la gestuelle à la communication verbale. L'intonation appartient au paraverbal et contribue au sens. Les préjugés et stéréotypes peuvent influencer la communication.

03 Identifier le besoin relationnel

L'enseignante le définit comme un **besoin d'entrer ou de rester en relation avec l'autre** pour exprimer, partager, comprendre ou traverser ce que l'on vit. Un soin techniquement programmé peut devenir le moment où ce besoin se révèle.

Situation travaillée

Une patiente de **45 ans**, à **J5 d'une mastectomie gauche** réalisée après un cancer du sein, exprime son inquiétude alors qu'un étudiant vient pour un soin. Sa phrase ne permet pas de savoir ce qui l'inquiète précisément : image corporelle, avenir, famille ou autre. Ces causes seraient des hypothèses, pas des faits.

Bon réflexe

« Vous dites que cela vous inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »

Le rôle relationnel n'impose pas de suspendre systématiquement un geste : on peut prendre un temps d'écoute, aménager le soin, prévoir un retour réaliste ou solliciter un relais pertinent, en respectant la situation.

04 Soin relationnel : du besoin à la réponse

Le **soin relationnel** est un accompagnement qui permet à la personne d'exprimer son vécu, ses émotions, ses représentations et ses besoins. Il s'articule aux soins techniques. La réponse n'est pas forcément une solution immédiate : permettre de parler est déjà un acte professionnel.

Ce que fait le soignant	Risque / intérêt
Accueille le propos et vérifie le sens	Reconnaît la demande réelle sans projeter son vécu.
Laisse la personne préciser	Favorise son expression et son pouvoir de décision.
Répond trop vite	Peut fermer l'échange ou minimiser le vécu.
N'a pas le temps immédiatement	Peut organiser une nouvelle disponibilité ou un relais avec l'équipe.

Méthode de réponse

Observer → reconnaître l'émotion exprimée → reformuler → questionner ouvertement → rechercher avec la personne une aide adaptée.

05 Les six attitudes de Porter

La grille des **six attitudes** sert à reconnaître la manière dont le soignant répond et l'effet possible de cette réponse sur l'espace de parole. L'enseignante insiste pour apprendre à **identifier les attitudes**, sans les transformer en interdictions absolues hors contexte.

Attitude	Exemple et effet possible
1. Évaluation / jugement	« Vous devez être forte » : appréciation pouvant culpabiliser.
2. Interprétation	« Vous avez sûrement peur de ne plus plaire » : cause supposée.
3. Soutien / réassurance	« Tout va bien se passer » : peut rassurer trop tôt sans preuve.
4. Investigation / enquête	« Est-ce le travail, les enfants ou le conjoint ? » : hypothèses imposées.
5. Solution / conseil	« Vous devriez consulter… » : proposition décidée par le soignant.
6. Compréhension	« Vous vous demandez comment vivre ce changement » : reprend le vécu exprimé.

À RETENIR

Les paroles changent d'effet selon le moment, la formulation et le vécu de la personne. La compréhension laisse de la place au récit ; les autres attitudes peuvent la réduire si elles interviennent trop tôt.

06 Porter : conséquences concrètes sur la relation

Les six attitudes ne sont pas des « bonnes » ou « mauvaises » phrases valables en toutes circonstances. L'enseignante demande d'en reconnaître les effets possibles et le contexte d'emploi.

Attitude	Risque si utilisée trop tôt	Alternative plus ouverte
Évaluation	Sentiment d'être jugé, culpabilité	Accueillir sans apprécier la réaction.
Interprétation	La patiente ne se sent pas comprise	Vérifier une hypothèse au lieu de la tenir pour vraie.
Soutien rapide	Fausse réassurance, émotion minimisée	Reconnaître l'inquiétude avant de rassurer.
Investigation	Entretien transformé en interrogatoire	Commencer par une question ouverte.
Solution / conseil	Sentiment d'être mis de côté	Rechercher d'abord besoins et ressources.
Compréhension	Élargit l'espace de parole	Reformuler l'émotion et laisser la personne préciser.

EXEMPLE AU BORD DU LIT

« Vous êtes inquiète et vous vous demandez comment vous allez vivre maintenant… Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? » La réponse n'attribue aucune cause non formulée et laisse place au silence.

De la conversation au soin relationnel

Une formule de civilité (« Il fait beau ») n'est pas automatiquement un soin relationnel. Le soin relationnel relève d'une intention professionnelle : le soignant repère un besoin, rend possible l'expression du vécu et ajuste sa réponse.

La présence d'un soin technique n'exclut pas l'écoute. Selon l'urgence, la disponibilité et le consentement, le soignant peut écouter sur-le-champ ou organiser un temps adapté avec l'équipe.

07 Reconnaître les réponses qui ferment le dialogue

L'enseignante montre notamment qu'une **bonne intention** ne garantit pas une **bonne réception** par la personne. La fausse réassurance ou le jugement ont parfois pour effet de minimiser l'inquiétude.

Réponse spontanée	Ce qui pose problème et alternative
« Soyez positive »	Peut laisser entendre que la personne réagit mal. Reconnaître d'abord l'inquiétude.
« Je sais ce que vous ressentez »	Suppose un vécu identique. Demander comment elle vit l'événement.
« Ce qui vous inquiète, c'est votre conjoint »	Interprétation : vérifier au lieu d'attribuer.
« Vous devriez faire ceci »	Conseil rapide : explorer les ressources et les souhaits.
« Ne vous inquiétez pas »	Réassurance incertaine : être présent sans promettre l'issue.

Piège de raisonnement

Ne jamais présenter une hypothèse du professionnel comme une émotion ou une priorité certaine du patient.

08 Carl Rogers et les trois attitudes de l'écoute active

L'écoute active est une **posture physique et intellectuelle**. La séance rattache à Carl Rogers trois composantes complémentaires :

Composante	Définition appliquée au soin
Empathie	Chercher à comprendre le monde de l'autre sans se confondre avec lui ou vivre nécessairement les mêmes émotions.
Considération positive inconditionnelle	Reconnaître la valeur, les capacités et les ressources de la personne, indépendamment de sa réponse.
Congruence	Alignement entre ce que le professionnel pense, dit et fait.

Empathie ≠ sympathie

La séance distingue une **compréhension professionnelle** du vécu de l'autre de la **proximité amicale** de la sympathie. Être empathique n'impose pas de se perdre dans ses propres émotions ; garder une posture chaleureuse ne signifie pas devenir l'ami du patient.

> **À RETENIR**
>
> La relation aide la personne à retrouver ou mobiliser ses ressources, et non à exécuter la solution choisie par le soignant.

09 Les techniques de l'entretien

Technique	Utilité et exemple
Question ouverte	Explore le vécu : « Qu'est-ce qui vous inquiète davantage ? »
Question fermée	Utile pour une information précise ou une réponse oui/non ; ne remplace pas l'expression libre.
Reformulation	Reprendre avec fidélité les mots : « Vous dites ne pas savoir comment vivre ainsi ».
Clarification	Faire préciser le sens : « Que signifie pour vous "comme avant" ? »
Silence	Laisser du temps pour réfléchir, ressentir et poursuivre le récit.
Valorisation	Reconnaître une capacité ou une ressource réelle, sans compliment automatique.

Pourquoi reformuler ?

La reformulation aide à **vérifier ce qui a été compris**. Le patient peut confirmer, nuancer ou corriger. La séance mentionne plusieurs formes de reformulation, notamment clarification et recadrage ; leur emploi reste lié au contexte et à l'objectif de compréhension.

> **À RETENIR**
>
> Questionner, reformuler, encourager et faciliter la parole rendent l'écoute réellement active. Un silence n'est pas automatiquement un refus.

10 Les quatre types de reformulation

La séance présente explicitement ces quatre catégories. Les reconnaître est plus précis que dire seulement « reformuler pour écouter ».

Type	Objectif et exemple
Reflet / miroir	Reprendre fidèlement ce qui vient d'être dit : « Vous voulez dire que… »
Résumé	Dégager les idées principales après un discours : « Si je comprends bien ce que vous m'avez dit… »
Recadrage	Mettre aussi en lumière une ressource ou un élément positif authentique, sans nier le ressenti.
Clarification	Faire préciser des propos ambigus : « Quand vous dites cela, qu'entendez-vous par là ? »

11 Le corps, la voix et le toucher dans la relation

La communication implique aussi les manifestations qui accompagnent ou remplacent les mots. Observer n'autorise pas à attribuer un état psychologique certain à partir d'un seul signe.

Canal	Repères évoqués
Verbal	Contenu des mots, type de question et reformulation.
Paraverbal	Voix, timbre, intensité, débit, rythme, silences.
Non verbal	Regard, position corporelle, distance, mimiques, éventuel toucher.
Toucher empathique	Contact de soutien relationnel, seulement adapté et accepté.
Toucher gnosique	Contact servant à recueillir des signes ou informations cliniques.

À RETENIR

Pour rester congruent, adapter la posture, le regard et la voix à la personne et à sa situation. Ne pas imposer le toucher ; tenir compte de son accord.

12 Les émotions du soignant et la distance relationnelle

Une situation peut provoquer **tristesse, malaise, stress, sentiment d'impuissance** ou peur de mal répondre. Le professionnel n'a pas à prétendre qu'il n'éprouve rien, mais doit reconnaître ces réactions et éviter qu'elles dirigent l'entretien.

Réflexe	Conséquence
Repérer ce qui résonne avec son histoire	Éviter de confondre sa propre émotion avec celle du patient.
Canaliser son émotion	Rester professionnel, disponible et respectueux.
Reconnaître l'altérité	La personne a ses valeurs, croyances et réactions propres.
Relayer si nécessaire	Passer la main lorsque l'intensité émotionnelle compromet l'écoute.
S'appuyer sur l'équipe	Partager les éléments utiles au soin selon les règles de confidentialité.

À RETENIR

La bonne distance ne signifie ni froideur ni familiarité : elle permet d'accompagner sans se laisser submerger et sans imposer son vécu.

13 Émotions, impuissance et juste présence

Le soignant peut ressentir de la tristesse, de l'impuissance, une gêne, une peur de mal répondre ou une envie immédiate de rassurer. Le repère professionnel n'est pas de supprimer ces émotions, mais de les reconnaître et de les réguler.

Question à se poser	Attitude professionnelle
Qu'est-ce que je ressens ?	Nommer intérieurement l'émotion et distinguer mon vécu de celui du patient.
Suis-je disponible ?	Canaliser mon émotion ; si nécessaire, passer le relais sans abandonner la personne.
Que puis-je faire ?	Écouter, soutenir, chercher les ressources de la personne et les relais adaptés.
Qui décide ?	Respecter la temporalité, les valeurs et les choix de la personne.

14 Situation intégratrice : après une mastectomie

Le cas de la patiente à J5 d'une mastectomie est repris en fin de séance. L'objectif est de construire une réponse professionnelle centrée sur elle, plutôt que d'inventer une explication à ses mots.

Étape	Exemple concret
1. Accueillir	S'arrêter quand c'est possible, posture calme, regard attentif.
2. Reconnaître	« J'entends que cette situation vous inquiète. »
3. Reformuler	« Vous vous demandez comment vivre ce changement. »
4. Explorer	« Qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »
5. Accompagner	Chercher avec elle ressources personnelles, entourage, équipe ou autre relais adapté.
6. Adapter	Tenir compte de son accord, du soin en cours et de son rythme.

Ce qu'il faut éviter

- Supposer que sa préoccupation concerne nécessairement son apparence, sa sexualité ou sa famille.
- Promettre une évolution favorable sans l'avoir évaluée.
- Abandonner le besoin relationnel à un autre professionnel sans avoir accueilli la parole.

15 Transmissions et ressources possibles

La relation d'aide ne repose pas sur une seule personne. L'enseignante évoque les échanges avec l'équipe soignante, le médecin, d'autres professionnels, les proches lorsque la personne le souhaite, ainsi que d'éventuelles associations ou ressources de soutien.

Question pratique	Piste de réponse
Que veut la personne ?	Explorer ses priorités avant de proposer une orientation.
Quelles ressources possède-t-elle ?	Repérer capacités, entourage, activité et stratégies déjà utilisées.
Quel relais proposer ?	S'appuyer sur l'équipe, sans renvoyer immédiatement toute difficulté ailleurs.
Que transmettre ?	Les faits et besoins utiles au suivi, dans le cadre professionnel approprié.

À RETENIR

L'orientation est une **proposition** à discuter avec la personne et non une prescription relationnelle immédiate.

16 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion fréquente	Distinction correcte
Empathie = sympathie	Comprendre sans se confondre ni imposer une relation amicale.
Soutenir = promettre	Écouter et soutenir sans garantir « tout ira bien ».
Question ouverte = liste d'hypothèses	Une question ouverte ne propose pas la réponse à la place de l'autre.
Reformuler = interpréter	La reformulation vérifie le sens ; l'interprétation en ajoute un sans preuve.
Silence = échec	Le silence peut laisser du temps et une place au récit.
Soin technique ≠ écoute	Les deux dimensions peuvent se conjuguer.
Distance = froideur	Rester présent tout en régulant ses propres émotions.

À retenir pour les partiels

- Les **six attitudes de Porter** doivent être reconnues en situation : évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution et compréhension.
- Les **trois repères de Rogers** : empathie, considération positive inconditionnelle, congruence.
- La **parole du patient** doit rester la référence : éviter les hypothèses transformées en certitudes.

17 Synthèse générale — l'essentiel du cours

Le cours part d'un besoin relationnel identifié en situation de soin, puis montre comment adopter une posture d'écoute adaptée. L'écoute est **active** car elle mobilise disponibilité, questions ouvertes, reformulation, clarification et respect du silence. Elle suppose un alignement entre parole et attitude, appelé congruence.

Les six attitudes de Porter aident à reconnaître les risques du jugement, de l'interprétation, de la réassurance hâtive, de l'enquête orientée et du conseil immédiat. Une attitude de compréhension ouvre davantage la possibilité d'exprimer un vécu.

Avec Carl Rogers, les repères essentiels sont l'empathie, la considération positive inconditionnelle et la congruence. La personne reste l'actrice de son parcours. Ses ressources, ses priorités et ses choix doivent être recherchés avant de proposer un accompagnement.

MÉMO DE RÉVISION

ACCUEILLIR → ÉCOUTER → REFORMULER → EXPLORER → RESPECTER → ACCOMPAGNER.

18 Définitions et mots-clés

Besoin relationnel

Besoin d'entrer ou de rester en relation pour partager et comprendre ce que l'on vit.

Soin relationnel

Accompagnement qui permet à la personne d'exprimer son vécu et d'être entendue.

Écoute active

Posture disponible et attentive qui mobilise l'écoute, la reformulation et le questionnement adapté.

Congruence

Accord entre pensées, paroles, attitudes et actes.

Empathie

Compréhension du monde de l'autre sans confusion avec sa propre histoire émotionnelle.

Considération positive inconditionnelle

Reconnaissance de la valeur et des ressources de la personne sans jugement conditionnel.

Attitudes de Porter

Six types de réponses : évaluation, interprétation, soutien, investigation, solution, compréhension.

Évaluation / jugement

Appréciation sur la façon dont la personne devrait réagir.

Interprétation

Attribution d'un motif ou d'un sens non formulé par la personne.

Soutien / réassurance

Tentative de réconfort pouvant parfois minimiser l'inquiétude.

Investigation / enquête

Exploration dirigée par les hypothèses du soignant.

Conseil / solution

Proposition de conduite à tenir formulée par le soignant.

Compréhension

Réponse qui reconnaît et reformule le vécu exprimé.

19 Définitions et mots-clés — suite

Question ouverte

Question laissant la personne développer librement son point de vue.

Question fermée

Question qui appelle une réponse limitée et précise.

Reformulation

Reprise du message pour vérifier et clarifier sa compréhension.

Clarification

Demande de précision sur un mot ou une idée ambiguë.

Paraverbal

Intensité, rythme, débit et timbre de la voix, pauses.

Non verbal

Regard, posture, distance, mimiques et autres signes corporels.

Proxémie

Ajustement de la distance corporelle entre les personnes.

Toucher empathique

Toucher exprimant une présence ou un soutien dans une relation adaptée.

Toucher gnosique

Toucher visant la recherche d'informations ou de signes cliniques.

Distance relationnelle

Position professionnelle qui associe proximité humaine et régulation de ses propres émotions.

Altérité

Reconnaissance de l'autre comme une personne ayant ses propres valeurs et représentations.

Mastectomie

Ablation chirurgicale d'un sein ; élément du cas clinique étudié.

Intention professionnelle

But identifié par le soignant pour répondre à un besoin relationnel repéré.

Relation de civilité

Échange de courtoisie qui ne correspond pas nécessairement à un soin relationnel.

20 Définitions et mots-clés — suite

Reformulation reflet / miroir

Restitution fidèle du propos pour vérifier la compréhension.

Reformulation résumée

Synthèse des éléments essentiels exprimés par la personne.

Reformulation recadrage

Mise en perspective ou valorisation authentique d'une ressource sans nier l'émotion.

Reformulation clarification

Demande de précision du sens d'une expression ambiguë afin de ne pas interpréter.

Symétrie dans l'échange

Ajustement de la posture et du niveau relationnel, notamment vis-à-vis d'une personne allongée.

Juste présence

Disponibilité relationnelle adaptée avec maintien des limites et des ressources du soignant.

Verbal

Contenu linguistique : mots et formulation.